

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	週邊置入中心靜脈導管照護評核表	編號	A31000-Q06-W-B43
	制定單位	護理部	版本	第 3.0 版
			修正日期	112 年 10 月 17 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：全院各單位（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 請受試者以口述法或實際演練法。
2. 查核交班單或護理記錄。

三、評核內容：

1. PICC 導管評估：

- a. 協助病人舒適擺位，露出 PICC 注射部位，並觀察注射部位有無紅、腫、熱、痛情形，以紙膠固定導管末端，移除舊的敷料時，應與皮膚平行，並朝向注射部位方向緩慢移除敷料，避免導管滑脫。
- b. 評估導管置入部位，將外露導管做一 U 型，目的在產生一個迴路緩衝，避免導管不慎拉扯滑脫。
- c. 每次更換時，需注意導管外露長度，並觀察導管是否有滑脫。

2. 消毒方式：

75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol 或是使用 2%Chlorhexidine 消毒，由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62 公分），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）

3. 固定方式：

- a. 戴上無菌手套，以無菌技術取出 Tegaderm 上紙膠條橫貼在外露導管的翼上。
- b. 使用 10×12cmTegaderm 黏貼覆蓋固定，並確認外露導管位置，於 Tegaderm 處註明換藥日、導管外露長度及注射部位的臂圍。

4. 管路換藥時機：

- a. 導管放置 24 小時後，應做第一次敷料更換，之後在正常情況下，每 7 天更換一次。
- b. 當導管放置處的傷口容易出血、滲血或是容易流汗時，應使用無菌紗布覆蓋傷口，且至少每天更換一次無菌紗布或視情況更換之。

